随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

不符合大量蛋白尿,不符合低蛋白血症,一定不是肾病综合征/题目只说大量蛋白尿,首先考虑肾病综合征

（2）**肾病综合征**　不能忽略肾炎综合征 水肿从眼睑面部开始时,不能直接锁定急性肾炎综合征而忽略肾病综合征

可能可能最可能：**大量蛋白尿/多+++及以上或＞3.5g/d、低蛋白血症/＜30、水肿（血浆胶渗压↓等）、高脂血症**

并发血栓及栓塞：最常累及**肾静脉——突发腰痛、血尿或蛋白尿加重、肾脏增大**。首选 **B 超**、最佳肾静脉造影，**白蛋白＜20 预防性抗凝**（肝素/华法林）、辅以抗板等

脂性肾病/微小病变性肾病/足突病 （踢足球的小子脏） T细胞的细胞免疫	**儿童**、青年多见 **典型肾病综合征（几乎无血尿、高血压）**	**光镜肾小球无明显异常、近端小管脂肪变性**，肾小囊脏层上皮细胞**足突融合消失**
膜性肾病 （中老年历经磨难吃鸡丁）	**中老年**多见 **最易并发肾静脉血栓**	**基膜明显增厚**、**钉状突起**、齿梳样、虫蚀样空隙，可有肾小囊脏层上皮细胞**足突融合消失**
系膜毛细血管性肾炎/膜增生性肾炎	几乎伴血尿、C_3 持续↓ 疗效差 激素抵抗	**系膜细胞和基质增生**并插入基膜和内皮间致**双轨/双线/分层征**

考法:题目给中老年、做穿刺活检看到钉状突起、足突融合消失　膜性肾病✓　脂性肾病✗

6.原发性肾小球疾病的治疗

急性肾炎	慢性肾炎	IgA 肾病	肾病综合征	急进性肾炎
对症	不以消除肾炎综合征为目标	分情况	**泼尼松+环磷酰胺**	
不用激素+环磷酰胺 无现症感染不用抗生素	**不用激素+环磷酰胺** 收缩压＜120、尿蛋白＜1	如**单纯血尿对症** **不用激素+环磷酰胺** 解决前驱感染即可	①**脂性肾病、局灶节段性肾小球硬化、系膜增生性肾炎：初治单用激素**（自己吸激） ②膜性肾病、系膜毛细血管性肾炎：初治用激素+环磷酰胺	①**血浆置换强化：I、III型，肺出血（Goodpasture）首选血浆置换**（好怕医生抽血） ②甲泼尼龙冲击强化：II、III型（三心二意激素强）

表 13-2　原发性肾小球疾病特点

类型	发病机制	光镜	电镜	免疫荧光	临床表现
急性弥漫性增生性肾小球肾炎	免疫复合物，循环或植入的抗原	弥漫性系膜细胞和内皮细胞增生	上皮下驼峰状沉积物	GBM 和系膜区颗粒状 IgG、IgM 和 C3 沉积为主	急性肾炎综合征
急进性肾小球肾炎	抗 GBM 型 免疫复合物型 免疫反应缺乏型	新月体形成	无沉积物 有沉积物 无沉积物	线性 IgG 和 C3 颗粒状 阴性或极弱	急进性肾炎综合征
膜性肾小球病	自身抗体与抗原原位反应	弥漫性 GBM 增厚，钉突形成	上皮下沉积物，GBM 增厚	基底膜颗粒状 IgG 和 C3	肾病综合征
膜增生性肾小球肾炎	Ⅰ型：免疫复合物 Ⅱ型：自身抗体，补体替代途径激活	系膜细胞增生、插入，基膜增厚，双轨状	Ⅰ型：内皮下沉积物 Ⅱ型：基膜致密沉积物	Ⅰ型：IgG+C3；C1q+C4 Ⅱ型：C3，无 IgG、C1q 或 C4	肾病综合征或血尿、蛋白尿或慢性肾衰竭
系膜增生性肾小球肾炎	免疫复合物沉积	系膜细胞增生，系膜基质增多	系膜区有沉积物	系膜区 IgG、IgM 和 C3 沉积	蛋白尿、血尿或肾病综合征
局灶性节段性肾小球硬化	不清，可能与循环性通透性增高因子作用有关；足细胞损伤	局灶性节段性玻璃样变和硬化	上皮细胞足突消失、上皮细胞剥脱	局灶性，IgM 和 C3	肾病综合征或蛋白尿
微小病变性肾小球病	不清，可能与肾小球阴离子丧失，足细胞损伤有关	肾小球正常，肾小管脂质沉积	上皮细胞足突消失，无沉积物	阴性	肾病综合征
IgA 肾病	免疫复合物，免疫调节异常	局灶性节段性增生或弥漫性系膜增宽	系膜区沉积物	系膜区 IgA 沉积，可有 C3、IgG 和 IgM	血尿或蛋白尿
慢性肾小球肾炎	具有原疾病类型特点	肾小球玻璃样变、硬化	因原疾病类型而异	因原疾病类型而异	慢性肾炎综合征、慢性肾衰竭